一页临床路径 | MOGAD 诊断与治疗

2025 · 条件与下一步按原文整理；诊断细则和特殊分支见提取表

1 核心事件：启动评估

视神经炎、脊髓炎、 ADEM 或其他核心脑部综合征→临床 /MRI 评估、尽量免疫治疗前送血清 MOG-IgG 。无核心事件者不能仅凭抗体确诊。

2025 p710–711

有核心事件，进入诊断评估

2 抗体条件与排除诊断

CBA≥1：100： 明确阳性；≥ 1：10 且 <1：100 、滴度未知或仅脑脊液阳性：另需 AQP4-IgG 阴性 +≥1 附加条件。均须排除其他病。

2025 p710–711

三部分满足，且处于急性发作

3 确诊急性发作：激素治疗

排除禁忌后尽早 IVMP ； 成人 1 000 mg/d×3~5 d 。儿童 20~30 $mg \cdot kg^{-1} \cdot d^{-1}$ 。改善→ 5 ；反应差 / 危重→ 4 。完整递减方案见提取表。

2025 p712 、 714–715

疗效不足或危重

4 救援： IVIG 或血浆置换

激素反应差可考虑血浆置换 5~7 次，每次 1.0~1.5 倍血浆容量；严重发作可联合 IVIG 。危重者可与激素同时启动置换；避免 IVIG 后立即置换。

2025 p712

稳定后

5 口服激素缓减与复评

口服激素减量过程≥ 6 个月。复评发作次数及残疾：稳定无复发→临床随访；首次严重且恢复差或发作≥ 2 次→ 6 。勿按抗体滴度单独停药。

2025 p708 、 710 、 712 、 714–715

符合序贯启动条件

6 符合条件：序贯预防复发

首次严重、恢复差（如 EDSS 仍≥ 2 分、视力仍 <0.6 ），或发作≥ 2 次，可考虑序贯治疗。选择免疫抑制剂 / 生物制剂 / 间歇 IVIG ，落实筛查与监测。

2025 p714–715

跨行分支： 3→5 治疗改善后

节点内条件优先；未列阈值不补编。完整证据、禁忌与特殊人群见提取表。